

CAPÍTULO 7.6

Coma Mixedematoso

PERFIL EUNACOM 1.03.2.004

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Coma Mixedematoso

Forma más grave del **hipotiroidismo**. **Letalidad: 30–50% (promedio 40%)**.

Clínica

Todo lo del hipotiroidismo + **compromiso de conciencia**:

- Hipotiroidismo base: intolerancia al frío, astenia, constipación, piel seca
- **Mixedema generalizado** (edema duro, sin fóvea) + macroglosia
- **Hipotermia** marcada
- Bradipnea (↓ frecuencia respiratoria)
- Bradicardia
- **Hiponatremia** (riesgo de muerte)
- **Hipoglicemia** (riesgo de muerte)
- Arreflexia generalizada

Diagnóstico

- Clínica + pruebas tiroideas
- **Primario**: T4 libre muy ↓ + TSH muy ↑
- **Secundario (hipofisario)**: T4 libre ↓ + TSH ↓ (+ posible crisis suprarrenal asociada)

Tratamiento — En orden estricto

- **Soporte**: ventilación mecánica si necesario + suero + manejo de hipoglicemia e hiponatremia
- **Corticoides EV** (hidrocortisona) primero → previene crisis suprarrenal al dar T4
- **Levotiroxina (T4) EV**: dosis de carga ~400 mcg → luego dosis alta de mantención
- - Si no hay EV disponible: vía SNG
- **T3 EV** adicionalmente → única situación donde se usa T3 terapéutica

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Monitorizar activamente: hiponatremia, hipoglicemia, signos vitales, estado de conciencia.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 78 años con antecedente de hipotiroidismo en abandono de tratamiento es traída en invierno a urgencias por compromiso de conciencia severo (estupor). Al examen: temperatura rectal 34.2 °C, PA 85/50 mmHg, FC 42 lpm, edema periorbitario duro y reflejos osteotendinosos con relajación muy lenta. Sodio: 122 mEq/L, Glicemia: 58 mg/dL."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Coma Mixedematoso: emergencia médica de alta letalidad. Tríada de Hipotermia + Hiponatremia/Hipoglicemia + Bradicardia e hipotensión con compromiso de conciencia. Manejo inmediato en UCI: (1) Hidrocortisona EV 100 mg c/8h (antes de T4 para prevenir crisis suprarrenal aguda); (2) Levotiroxina EV/SNG dosis de carga; (3) Calentamiento pasivo; (4) Manejo hidroelectrolítico cuidadoso con suero salino hipertónico si hiponatremia sintomática grave.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Coma mixedematoso: forma más grave de hipotiroidismo. Letalidad 30-50% (promedio 40%).
- Clínica: compromiso de conciencia + mixedema generalizado (edema duro sin fóvea) + hipotermia + bradicardia + bradipnea + hiponatremia + hipoglicemia + arreflexia.
- Tratamiento ordenado: 1° soporte, 2° corticoides EV (hidrocortisona), 3° levotiroxina EV (carga 400 µg), 4° T3 EV.
- Los corticoides se dan ANTES de la levotiroxina para evitar descompensación por insuficiencia suprarrenal asociada.
- Es una de las pocas excepciones donde se usa T3 como parte del tratamiento.
- Monitorizar hiponatremia e hipoglicemia continuamente, ambas pueden ser mortales.

EUNACOM CRITERIOS

Orden obligatorio: corticoides **antes** de la T4. Si se da levotiroxina sin cubrir el cortisol → crisis suprarrenal grave.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMA MIXEDEMATOSO)

PREGUNTA 1

Paciente de 70 años traído por familiares por compromiso de conciencia progresivo. Al examen: hipotermia (34°C), bradicardia (45 lpm), edema duro generalizado sin fóvea, arreflexia. Laboratorio: Na 118 mEq/L, glicemia 45 mg/dL. ¿Cuál es la primera medida farmacológica específica después del soporte vital?

- A) Levotiroxina endovenosa en dosis de carga
- B) Hidrocortisona endovenosa
- C) T3 endovenosa
- D) Metimazol endovenoso
- E) Solución glucosada hipertónica

RESUMEN: COMA MIXEDEMATOSO

El coma mixedematoso es la forma más grave del hipotiroidismo con alta letalidad (30-50%, promedio 40%). Presenta toda la clínica del hipotiroidismo agravada con compromiso de conciencia, mixedema generalizado (edema duro sin signo de fovea), macroglosia, hipotermia, bradipnea, bradicardia, hiponatremia, hipoglicemia y arreflexia generalizada. El diagnóstico se hace con clínica más pruebas tiroideas (T4 libre muy disminuida, TSH muy elevada en primario o baja en secundario hipofisiario). El manejo requiere: soporte vital (ventilador mecánico, suero, manejo de hipoglicemia), corticoides endovenosos primero (hidrocortisona, por posible insuficiencia suprarrenal asociada), levotiroxina endovenosa con dosis de carga de 400 µg, y T3 endovenosa. Esta es una de las pocas excepciones donde se usa T3 como tratamiento.